核心精讲

肠梗阻

性感认识：痛吐胀停

「理顺知识点」

- 肠管不通畅导致的肠梗阻→机械性肠梗阻（可以是肠腔内阻塞或肠管外压迫）
  - 最常见的肠梗阻是粘连性肠梗阻
- 麻痹性肠梗阻、痉挛性肠梗阻、绞窄性肠梗阻可导致肠道失去有效的蠕动

一、主要病因和治疗

外科　肠梗阻&阑尾炎1
00:03:19--00:09:13

1. 腹部手术、损伤或炎症史：粘连性肠梗阻（最常见）。粘连越广发生肠梗阻的几率越大、但不代表肠梗阻越严重。先保守治疗
2. 新生儿：肠道先天性畸形。手术为主
3. ≤2岁多见：肠套叠

   ①腹痛、腹部肿块、果酱样血便

   ②钡灌肠（兼治疗作用）弹簧或杯口状（2岁弹杯子装的果酱）；>2天手术为主（222儿）

「理顺知识点」

- 钡灌肠：既可以诊断（杯口征、弹簧征）+治疗（钡剂灌注产生的液压压力，可能使肠套叠部位得以复位）

4. 儿童：蛔虫团（单纯不完全性梗阻）。先保守治疗（驱虫）

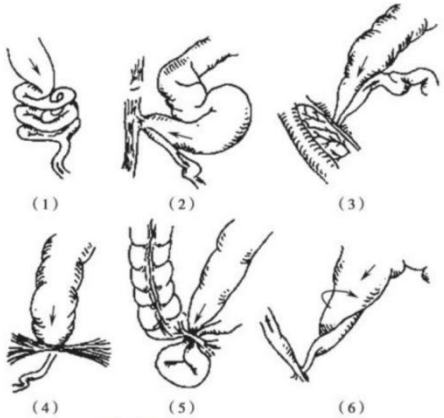


图 39-1　各种类型的粘连性肠梗阻

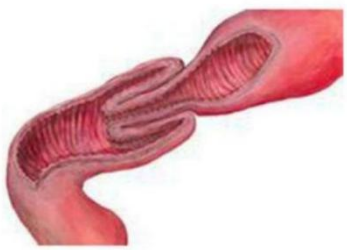
(1)肠袢粘连成团　(2)腹壁粘着扭折　(3)系膜粘着扭折
(4)粘连系带　(5)粘连内疝　(6)粘连成角，扭转

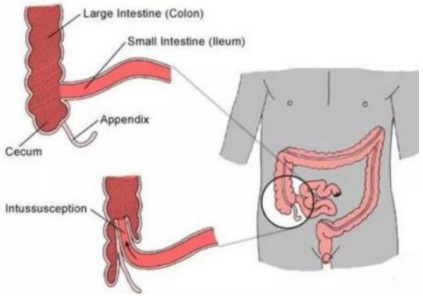


图 39-2　回结肠套叠









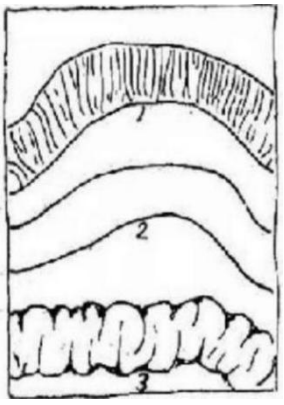
二、可能可能最可能：痛吐胀停

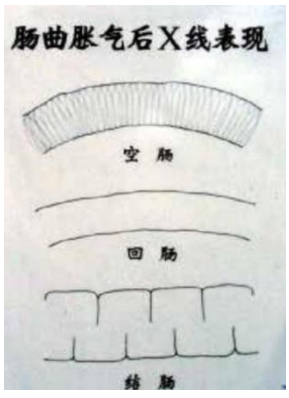
外科　肠梗阻&阑尾炎1
00:03:19--00:22:09

腹痛	阵发性绞痛→机械性 持续性胀痛或不适→麻痹性
呕吐	呕吐早而频繁、可合并代碱→高位（空肠）类似幽门梗阻 呕吐较晚、含粪样物→回肠 呕吐不明显→大肠
腹胀	腹胀不明显、可见胃型、X线鱼骨刺状/鱼肋征→高位（空肠） 腹胀明显、可见胃肠型、X线阶梯状液气平→低位（回肠、大肠） 腹胀均匀对称→麻痹性
排便排气	停止→完全性 尚有→不完全性
肠鸣音 （正常4-5次/分）	肠鸣音增强→机械性（亢进呈金属音调）、痉挛性（如急性肠炎、铅中毒） 肠鸣音减弱→麻痹性（如腹腔内出血、腹膜炎、腹水、低血钾、阿托品、阿片药、中毒性巨结肠）

「理顺知识点」

- 阵发性绞痛：肠管不通畅→平滑肌加强蠕动→绞痛→长时间收缩致肌肉疲劳（阵发性）
  - VS.胆囊结石、泌尿结石
- 持续性胀痛：肠外因素抑制肠蠕动→气体、液体积聚→持续性胀痛
- 呕吐与腹胀相反：若呕吐明显，吐出大量消化道内容物，腹胀减轻
- 肠内因素刺激肠子→肠鸣音↑；肠外因素刺激肠子→肠鸣音↓
  - 低血钾→骨骼肌、平滑肌无力→肠鸣音↓
  - 阿托品（M-R 阻断剂）：阻断平滑肌 M-R→平滑肌舒张→肠鸣音↓
  - 阿片药：舒张平滑肌→肠鸣音↓
  - 溃疡性结肠炎的并发症-中毒性巨结肠的本质：麻痹性肠梗阻



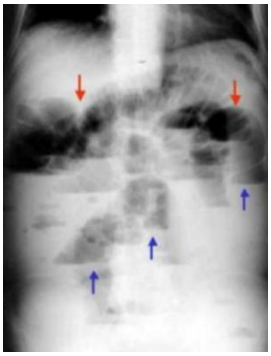












三、肠扭转

外科　肠梗阻&阑尾炎1
00:22:09--00:30:38

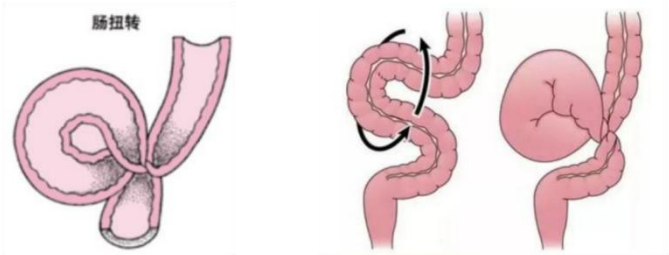
1.概述

①肠袢及其系膜过长、系膜根部附着处过窄或粘连收缩靠拢、肠内容物骤增、肠管动力异常、突然改变体位

②小肠、盲肠、横结肠以顺时针扭转多见，乙状结肠以逆时针扭转多见。小肠扭转最多见

2.可能可能最可能（青年人打篮球-小肠-年龄小　VS　老年人打太极-大肠-年龄大）

青年饱餐后剧烈运动多致小肠扭转	便秘的老年运动多致乙状结肠扭转
回转复位扭转肠袢 若坏死→肠切除+一期吻合术	钡灌肠（兼治疗作用）鸟嘴征，X线马蹄状巨大双腔充气肠袢 回转复位扭转肠袢，若坏死→肠切除+造口







四、治疗

外科　肠梗阻&阑尾炎1
00:30:38--00:44:19

1.最基本：禁食补液、胃肠减压

2.手术

（1）已绞窄

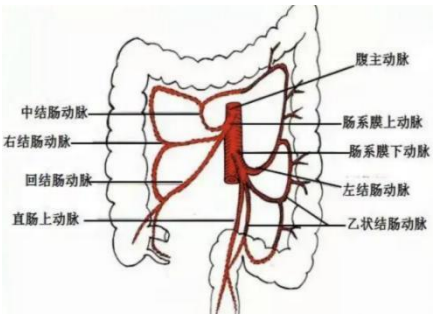
持续腹痛伴阵发加剧，压痛固定

X线孤立固定的肿大肠袢（不随时间变化）

腹痛可暂时减轻、随后出现腹膜炎

早期休克

血性呕吐物、排泄物、腹水





「理顺知识点」

- 肠道每天会分泌大量液体，一旦发生肠梗阻，就会发生明显的水、盐电解质失衡
- 腹痛可暂时减轻：提示穿孔，穿孔后肠道内压力骤降，因此腹痛可暂时减轻，肠道内容物进入腹腔可引起腹膜炎（腹膜刺激征）

（2）易绞窄

①急性完全性梗阻

②肠套叠

③闭袢性梗阻：肠扭转、大肠完全梗阻、结肠-结肠型套叠、逆行性嵌顿疝、急性完全性输入袢梗阻（出现肠绞窄如腹膜炎→手术，否则先保守治疗、无效再手术）

④有心脏疾患的老年人：房颤等病史→栓塞肠系膜上动脉等（以中结肠动脉常见）→急腹症：症征不符（早期腹痛等症状严重、腹部体征轻微）→腹腔动脉造影

「串联」

- 房颤不能贸然的转复，以免心房突然恢复有效收缩使附壁血栓脱落，造成脑栓塞、肠系膜上动脉栓塞等
- 外科学常考：急腹症+房颤病史→附壁血栓脱落进入体循环堵塞肠系膜上动脉栓塞

真题解析·肠梗阻

外科　肠梗阻&阑尾炎1
00:58:01--01:26:16

1.2013N85A男性，82岁。前天饮酒后出现腹部胀痛，小便频，量少，逐渐加重。平时大便干燥，2-3天1次。查体：腹部膨隆，下腹为著，全腹压痛，下腹更重，肌紧张不明显，肠鸣音活跃。经肥皂水灌肠后，排出较多粪块，腹痛无明显缓解。该患者最可能的诊断为

A.急性膀胱炎　常见于年轻女性+尿频尿急尿痛

B.急性尿潴留　乙醇抑制ADH分泌；饮酒本身可导致前列腺充血→加重前列腺肿大

C.习惯性便秘

D.乙状结肠扭转　　要有体位改变、肠道内容物增加以及运动后的病史

2.2013N111-113A男性，80岁。因突发全腹剧痛8小时来院，途中频繁呕吐，随后出现气急、喘憋。既往有房颤史。入院查体：P95次/分，BP84/60mmHg，急性病容，呼吸急促，两肺均可闻及哮鸣音及湿啰音，右侧为著，心率120次/分，节律不整，腹部膨隆，全腹均有压痛，右侧更明显，轻度反跳痛，肌紧张，肠鸣音弱。化验Hb124g/L，WBC30×10^9/L，中性粒细胞90%。

111.对该患者即刻应采取的处理措施是

A.快速补液加升压药

B.增强CT　　急腹症+房颤病史→附壁血栓脱落导致肠系膜上动脉栓塞

C.血管造影

D.减慢心率

112.患者突发严重的喘憋可能的原因是

A.急性心衰

　答案：1-2 B ADD

B.哮喘发作

C.肺栓塞

D.吸入性肺炎

113.患者的以下拟诊中可排除的是

A.上消化道穿孔

关注主诉、关注原发部位

B.肠系膜上动脉栓塞

C.急性重症胰腺炎

D.乙状结肠扭转

3.2017N100-102A男性，35岁，4小时前吃枣时误服一枚枣核，现感腹痛，无呕吐、无排便。

100.该病人可能发生的最严重情况是

A.幽门梗阻

B.消化道穿孔

C.回盲瓣梗阻

D.消化道黏膜损伤

101.判断有无上述严重后果的最简单有效的方法是

A.B超

B.CT

C.腹部物诊检查

D.消化道造影

102.经过一天观察，腹痛减轻，仍未排便。此时的处理措施是

A.胃镜检查

B.结肠镜检查

C.口服液体石蜡油

D.开腹探查，取出异物

4.2019N93-94A男性，67岁。3小时前突发脐周绞痛，面色苍白，大汗，2小时后疼痛减轻，出现腹胀。有心房颤动病史。查体：全腹压痛、反跳痛、轻度肌紧张，移动性浊音可疑，肠鸣音弱。

93.最可能的诊断是

症征不符

A.重症急性胰腺炎

B.急性肠扭转

C.肠系膜上动脉栓塞

　答案：3-4 BCC CD

D.上消化道穿孔

94.最有诊断意义的检查是

A.血淀粉酶测定

B.腹部B超检查

C.立卧位腹部平片

D.选择性腹腔动脉造影

5.2021N64A下列不属于绞窄性肠梗阻的典型临床表现是

A.早期出现休克

B.腹膜炎体征

C.腹胀

D.血便

6.2023N132−133B

A.结肠癌

B.肠套叠

C.乙状结肠冗长

D.粘连性肠梗阻

老年人结肠梗阻最常见的病因是

儿童肠梗阻最常见的病因是

7.2023N162X下列关于肠系膜上动脉栓塞的叙述，正确的有

A.腹痛症状多较剧烈

外科干扰选项：部位

B.腹部体征早期较为轻微

C.栓塞多发生在肠系膜上动脉根部

D.选择性腹腔动脉造影有助于明确诊断

8.2024N161X肠系膜上静脉血栓形成的原因有

A.肝硬化门静脉高压症

B.腹腔感染　　回顾生理：促进血小板聚集的物质−致聚剂（大多数），除NO、PGI2

C.真性红细胞增多症

D.脾切除术后　①血小板破坏↓，血小板数量↑，容易生成血栓②长期卧床容易形成血栓

　答案：5−8 C AB ABD ABCD

9.2025N96-97A男性，68岁。阵发性下腹痛1周，加重3天伴停止排气排便来诊。既往体健。查体：BP 130/80mmHg。腹部膨隆，全腹压痛，下腹部为重，无肌紧张，肠鸣音亢进。化验：血WBC12×10^9/L，腹部X线平片提示小肠扩张，多发气液平。

96.最可能的诊断是

A.上消化道穿孔

B.机械性肠梗阻

C.重症急性胰腺炎

D.急性化脓性阑尾炎

97.下列检查方法中不宜采用的是

A.腹部CT

B.钡剂上消化道造影

C.结肠镜

D.钡剂灌肠

钡餐禁忌症：①消化道穿孔②完全性梗阻

小结：

	小肠扭转	乙状结肠扭转
方向	顺	逆
好发人群	青年	老年
看主诉	饱餐+运动等体位改变	便秘+运动等体位改变
关注原发部位	脐周绞痛	左下腹绞痛
呕吐	早而频繁	不明显、晚期可少量粪样物
腹胀	以某处特别明显	全腹明显，左下腹更明显
排便排气	完全性梗阻则停止排便排气	
肠鸣音	亢进，若坏死则减弱消失	
影像	CT最佳（空回肠换位征） 漩涡征（排列成多种形态的小跨度蜷曲肠袢）	钡灌肠鸟嘴征（兼复位治疗） 马蹄状巨大双腔充气肠袢 阶梯状液气平、结肠袋形
最基本治疗	禁食补液、胃肠减压	
最重要治疗-及早手术（闭袢易较窄）	回转复位扭转的肠袢	
	若坏死→肠段切除，一期吻合	若坏死→肠段切除，造口

　答案：9 BB